

10 - 02-Gestes et soins d'urgences niveau I partie II - Pr. T.ABOU ELHASSAN

Gestes et soins d'urgence niveau 1 pour la deuxième année de médecine, la deuxième partie. Rappelez-vous qu'au sommaire de ce module, il y a le premier point, alerte protection, deuxième point, l'arrêt cardiaque chez l'adulte, troisième point, l'obstruction des voies aériennes supérieures, le quatrième point, hémorragie et enfin un patient inconscient. La dernière fois on a vu alerte protection, aujourd'hui on va faire l'obstruction des voies aériennes supérieures, l'hémorragie et le patient inconscient.

Obstruction des voies aériennes supérieures. L'obstruction des voies aériennes supérieures est une des situations qui n'est pas négligeable dans la vie quotidienne, qui guette d'un geste salvateur simple si l'obstruction est totale. Ces situations-là se voient surtout chez les enfants et les sujets âgés, et en décline, deux situations différentes d'obstruction des voies aériennes supérieures de prononciation complètement différente.

D'une part, la situation la plus grave, c'est l'obstruction totale des voies aériennes supérieures et la deuxième situation, c'est l'obstruction partielle des voies aériennes supérieures. Qu'en est-il de l'obstruction totale ? L'obstruction totale, on rappelle que c'est une grande urgence vitale, le risque c'est l'arrêt cardiaque et le décès par asphyxie. Le geste salvateur va être constitué des obstructions en urgence par une manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Henlich.

Lors de l'obstruction totale, le patient ou la victime va se présenter comme tel, comme vous voyez sur la photo. Alors, regardez bien, très bien la photo. Le patient, il porte ses mains à la gorge anxieuse.

Le patient est anxieux. Le patient ne peut pas parler ou ne peut pas crier lorsqu'on est devant un enfant. Le patient, il va garder la bouche ouverte, comme il fait pour rappeler de l'air, parce qu'il est complètement obstrué et ne peut pas respirer ou respirer d'une façon bruyante.

Le patient ne peut pas tousser. Le patient devient rouge, puis il devient bleu par asphyxie. Et si on pose la question à la victime, est-ce que vous étouffez? Il peut répondre oui en hochant la tête et il ne peut pas parler.

Devant cette situation là, le risque, c'est que le patient va perdre connaissance par hypoxie cérébrale et le risque aussi, c'est l'arrêt cardiaque comme on l'a vu. Et dans ce cas, il faut essayer de désobstruer d'une façon urgente. Comment ça se passe la manœuvre de Hemlich chez l'adulte? Il se passe sur quelques étapes.

La première étape, une fois dans cette situation là, le sauveteur qu'on voyait dans l'image, il tape, il donne des claques sur le dos de la victime, généralement cinq claques. Le sauveteur doit maintenir qu'on voyait la victime parce qu'il y a un risque de troubles de conscience et un risque que le vactime va s'évanouir. Et dans ce cas là, donc, il faut maintenir la victime pour éviter cette

situation là.

Deuxième étape, il faut procéder à une compression abdominale et qu'on voyait sur la photo à gauche. On va s'aider avec les deux points au niveau de la région sus ombilical en se tenant derrière la victime et en le maintenant et on fait des mouvements brusques de pression sur l'abdomen pour essayer d'éjecter ou de faire éjecter le produit par la bouche. Chez la femme enceinte, c'est une situation qui n'est pas négligeable.

Dans ce cas, la compression va se faire au niveau du thorax. Il ne faut pas faire de pression au niveau de l'abdomen parce qu'il y a un risque pour le fœtus. La compression thoracique peut se faire aussi chez l'obèse.

L'obstruction totale de voyants supérieurs chez le nourissant et l'enfant est aussi fréquente. Dans ce cas là, on va essayer comme chez l'adulte de donner cinq claques sur le dos en maintenant le nourissant ou le petit enfant par la main. Le sauveteur s'assoit sur une chaise.

La victime ou le nourissant est penchée devant, on donnerait cinq claques, puis on retourne l'enfant pour faire les compressions par les deux doigts dans la même région pour essayer d'extraire le corps étranger. Deuxième cas de figure, l'obstruction partielle. La clinique est légèrement différente par rapport à l'obstruction totale.

La victime peut tousser d'une façon vigoureuse, alors que l'obstruction totale, la victime ne peut pas tousser. La victime respire toujours et reste consciente. Dans l'obstruction totale, la victime ne peut pas respirer et rapidement il devient inconscient.

La victime peut s'exprimer et demander de l'aide, alors que dans l'obstruction totale, la victime ne peut pas parler. La victime dans l'obstruction partielle peut présenter des signes de lutte respiratoire. Quels sont les risques dans l'obstruction partielle? Généralement, si la victime est mise en attente, il n'y a pas de risque.

Le risque important, c'est de transformer une obstruction partielle en obstruction totale, si on va s'acharner à faire extraire l'objet étranger par la main ou par un objet. Les gestes à faire dans ce cas là, il faut rassurer la victime, il faut chercher des signes de détresse vitale, notamment les troubles neurologiques, l'air respiratoire ou même l'air écaliac. Surtout, il ne faut pas essayer d'enlever l'objet étranger sous risque de la transformer en obstruction totale.

Encourager la victime à tousser et appeler de l'aide. Et dès qu'on a de l'aide, il faut administrer de l'oxygène si possible. Après, la victime va être envoyée à l'hôpital où un bilan radiologique va être fait et la programmation d'une extraction second étranger selon le cas.

D'une façon générale, cet arbre incisionnel va répéter tout ce qu'on a dit auparavant. Généralement, la victime s'étouffe. On ne sait pas si c'est totale ou partielle.

L'objectif, c'est de s'obstruer lorsqu'on est devant l'obstruction totale des voies aériennes supérieures. Deuxième élément, on va demander à la victime, est-ce que vous vous étouffez ? Si la victime peut parler, dans ce cas-là, il faut encourager la toux, garder la position, rechercher des signes d'être vital et demander un avis médical spécialisé et administrer de l'oxygène autant que possible. Si par contre la victime ne peut pas parler, dans ce cas-là, nous sommes bel et bien devant une obstruction totale.

On va passer à la procédure de la destruction des voies aériennes supérieures par la manœuvre des Heimlich qui est étalée sur trois étapes globalement, dont les cinq claques sur le dos. Après, on va évoluer cette attitude-là. Si la victime peut parler, on va passer à l'encouragement de la victime, garder la position et chercher des signes d'être vital.

Si la victime ne peut pas parler après les cinq claques sur le dos, dans ce cas-là, on passera aux cinq compressions d'abdomen. Encore une fois, si la victime peut parler, la situation d'urgence est dépassée, on va encourager la victime à la toux et garder la position en recherchant des signes d'être vital. Si la victime, après les cinq compressions d'abdomen, toujours n'arrive pas à parler, on va évoluer la conscience.

Si la victime ne réagit pas, dans ce cas-là, il faut allonger la victime et réaliser la réanimation cardiopulmonaire de base qu'on va voir dans un autre topo. Maintenant, on va passer à une autre situation de secourisme, l'hémorragie. L'hémorragie signifie quoi? C'est un saignement abondant, non contrôlé, qui est visible par la victime, qui est extériorisé.

C'est une situation qui laisse une angoisse chez la victime et chez l'entourage. Le geste de secourisme, stopper le saignement. Sur la photo en bas, lorsqu'on a une plaie sur ce modèle de bouteille, si on a une plaie à ce niveau-là, et si on n'arrête pas le saignement, la victime va se vider de son sang et va passer en une situation qu'on appelle un état de choc hémorragique.

S'il n'est pas régulé, la victime peut mourir. Les risques, comme on l'a vu, c'est que la victime peut se vider du sang et dans ce cas-là, cliniquement, il va y avoir des protensions artérielles avec comme risque, à la limite, un arrêt cardiaque si le saignement n'est pas arrêté. Devant cette situation-là, comme on l'a toujours vu dans toutes les situations de secourisme, il faut chercher les signes de gravité.

Les signes de gravité vont se voir si on a un saignement important, si on a une perte de son importante et aussi rapide. Comment on va juger la gravité en pré-hospitalier ou chez la victime en dehors de l'hôpital, on va mettre un mouchoir, s'il est imbibé en quelques secondes, là, la situation est assez sérieuse. Cliniquement, la victime va devenir pâle, il va avoir une peau froide, il va avoir surtout de la soif, il va avoir des sueurs, il va avoir des signes respiratoires et après, il va s'agiter par hypoxie cérébrale et il devient inconscient.

Ça, ce sont les signes de gravité mais d'une façon très pratique, c'est généralement la soif qui

doit attirer beaucoup plus l'attention avec la respiration rapide. Dans ce cas-là, il faut surtout attendre l'apparition de ces signes-là pour agir. Le geste facilement, c'est d'arrêter le scéniement.

Dans ce cas-là, il faut que je me protège par un gant, par un sachet à platique et puis on appuie sur l'appli. Deuxième geste salvatoire à faire, c'est d'allonger la victime et en continuant à appuyer sur l'origine de scéniement, sur la plaie. C'est les deux gestes à faire, allonger la victime, appuyer sur la plaie et tout en se protégeant.

Comment on va faire cet appui sur la plaie ? Là, c'est un exemple d'une plaie par arme tranchante et comme vous voyez sur la photo, le sauveteur a appuyé sur l'origine de la plaie mais regardez très bien, sans aucune protection. Donc il faut toujours se protéger, il faut toujours mettre un gant, il faut toujours mettre du plastique si on est en dehors d'hôpital. Le sauveteur doit toujours se protéger avant d'agir.

La compression peut être manuelle. Regardez, la victime est allongée, le sauveteur appuie à ce niveau-là de façon manuelle, ce qu'on appelle la compression directe manuelle. On peut, si le sauveteur doit se libérer pour aller à l'armée, il posera ce qu'on appelle un tampon relais.

Donc il a mis un tampon et puis on fait ce qu'on appelle un tampon relais. Si le tampon relais est posé ou si le pansement est posé, il ne faut jamais le retirer. Même si le pansement est imbibé de sang parce qu'on risque d'arracher des cailloux en cours de formation et de relancer l'hémorragie.

Ça, il ne faut pas le faire. Troisième éventualité pour arrêter le scéniement, dans certaines situations très dangereuses, très graves, c'est la mise en place qu'on appelle un garrot. Un garrot, c'est un procédé qu'on va mettre pour arrêter le scéniement et dans ce cas-là, c'est les hémorragies qui sont extrêmement importantes.

C'est les hémorragies qui surviennent lorsqu'on est devant plusieurs victimes et on est un sous-sauveteur. C'est les hémorragies qui surviennent après échec de la compression manuelle, après échec de la compression indirecte, après échec de la mise en place des tampons. Dans ce cas-là, on passera au troisième niveau pour arrêter le scéniement, c'est la mise en place d'un garrot.

Mais il faut noter très bien que le garrot ne doit jamais être défait, il ne doit jamais être retiré, sauf au niveau d'une structure hospitalière, notamment au niveau d'un bloc opératoire. Si on a un scéniement, une plaie ou une hémorragie en présence d'un cas étranger. Dans ce cas-là, il faut laver à l'eau de rubiné et ne jamais retirer le corps étranger jusqu'à une exploration chirurgicale.

D'autres situations qui peuvent se présenter lorsqu'on est devant une victime qui a une plaie au niveau de l'abdomen. Quelle est la position avec laquelle on va mettre la victime ? On a vu généralement qu'il faut allonger les victimes en décubitus dorsal, en faisant des pansements ou des tamponnements. Lorsqu'on est devant une plaie de l'abdomen, on va allonger la victime, qu'on voit sur la photo à gauche, et il faut surélever les membres inférieurs pour améliorer le

retour veineux et pour améliorer l'état hémodynamique.

Deuxième cas de figure, lorsque la victime a une plaie de thorax par arme blanche, la position d'attente dans ce cas-là, il faut que la victime soit mise non pas en décubitus dorsal, mais plutôt en position demi-assise. Lorsque la victime a une plaie au niveau du cou, dans ce cas-là, il faut faire une compression manuelle au niveau du cou contre le rachis cervicale pour essayer d'arrêter le saignement. Là, c'est un tamponnement par compression manuelle qu'il faut faire.

Lorsque la victime présente des épistaxis, c'est le saignement nasal qu'on voit, dans ce cas-là, il ne faut pas se pencher derrière, comme on le fait toujours, mais plutôt il faut se pencher devant et faire une compression modérée sur la narine qui saigne au niveau de la narine qui saigne et la victime doit se pencher devant. Comme algorithme, la victime saigne d'une façon abondante, l'objectif c'est d'arrêter le saignement. Il faut allonger la victime dès que possible et commencer ce qu'on appelle la compression directe locale par la main protégée.

Si le sauveteur peut se libérer, dans ce cas-là, il faut mettre un pansement compressif. Si le sauveteur ne peut pas se libérer, dans ce cas-là, il faut allonger la victime et faire alerter ou alerter le secours tout en surveillant l'état du patient, mais surtout l'arrêt du saignement. Si, après la pose d'un pansement compressif, on doit juger l'efficacité, si on est efficace, on va allonger la victime et alerter tout en surveillant la victime.

Si le pansement compressif est jugé non efficace, on doit mettre un deuxième pansement compressif qu'on va juger encore une fois son efficacité. Si il est efficace, allonger la victime et alerter tout en surveillant l'arrêt du saignement. Si le deuxième pansement compressif n'est pas efficace, dans ce cas, on fera ce qu'on appelle une compression directe locale et il faut alerter, allonger et surveiller le saignement.

Les hémorragies, ils y sont fréquents. L'évolution est parfois fatale si on n'intervient pas. Les gestes de compression sont simples et faciles.

Il faut toujours rappeler avant d'aller toucher du sang, il faut toujours se protéger et alerter et surveiller chaque acte qu'on fasse chez la victime. Quatrième item, victime inconsciente. On va s'aider avec cet algorithme pour voir ce qu'on va faire lorsqu'on est devant une situation où la victime est inconsciente.

Dans ce cas-là, la victime est inconsciente et respire. C'est la première des choses à faire, c'est d'évaluer la respiration. Il faut libérer les voies aériennes supérieures pour permettre à la victime de respirer.

On va voir comment on va faire, on va voir la situation d'attente ou la situation d'attente sur laquelle on va travailler. Mais dès que vous êtes devant une victime qui est inconsciente, il faut évaluer la respiration. Est-ce que la victime respire ou non ? Parce que s'il ne respire pas, dans ce cas-là, c'est l'arrêt cardiaque, il faut qu'on passe à ce qu'on appelle la réanimation cardio-

pulmolaire.

Si par contre la victime est inconsciente, on a libéré les voies aériennes supérieures et elle respire, dans ce cas-là, il faut appeler de l'aide, essayer de libérer les voies aériennes supérieures et après évoluer. Si la victime respire, dans ce cas-là, on va mettre ce qu'on appelle la mise sur le côté ou la position latérale de sécurité et on va alerter ou faire alerter. Si la victime ne respire pas, dans ce cas-là, c'est un patient ou une victime en arrêt cardiaque et la réanimation cardio-pulmolaire de base doit être démarrée sans attendre.

Une fois la victime émise sur le côté dans la position latérale de sécurité, la PLS, on doit toujours évaluer la respiration au fur et à mesure, pratiquement toutes les minutes, jusqu'à l'arrivée des équipes spécialisées de secourisme. Mais c'est quoi la technique avec laquelle on va mettre une victime en position latérale de sécurité ? Sur l'image, vous avez une victime qui est inconsciente, tombée par terre. Le sauveteur va libérer les voies aériennes supérieures en faisant une subluxation et une hyperextension de la tête pour libérer les voies aériennes supérieures.

Il va évaluer la respiration pour répondre à la première question, est-ce que la victime respire ou non ? Dans ce cas-là, la victime a été évaluée comme étant une victime inconsciente mais qui respire. On va procéder au proprement dit de la pollution, la mise en position latérale de sécurité. Le sauveteur va allonger complètement le patient ou la victime.

Le bras à droite ou à gauche, c'est n'importe quelle position, soit à droite soit à gauche, elle est mise dans cette position. Après, on va empommer l'autre main de la victime avec la main du sauveteur et on va essayer de le faire rouler sur la position latérale. Le sauveteur a choisi la position latérale de sécurité à droite.

Après, l'autre main va être servie comme étant un coussin sous la joue de la victime et la position définitive de latérale de sécurité va être faite de cette façon-là. Vous regardez, avec cette position-là, la victime ne risque pas de s'enrouler ou de partir en déguise dorsale ou en déguise ventrale et le secouriste va continuer à surveiller essentiellement la respiration.